

Phénoménologie et analyse existentielle II

Livret d'accompagnement du CM 2025-2026

PHILIPPE SPOLJAR

Courriel : philippe.spoljar@u-picardie.fr

Présentation

Sommaire

PRÉSENTATION

SOMMAIRE

I. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA FATIGUE ET CLINIQUE DE LA DÉPRESSION

Introduction

1.1. Les « sentiments corporels »

1.1.1. Définition et spécificité

1.1.2. Le pré-sensoriel et le sensoriel

1.2. Vécus de fatigue

1.2.1. Le « vécu de pouvoir »

1.2.2. Le « vécu de valoir »

1.3. Fatigue et épuisement

1.3.1. Sémiologie différentielle

1.3.2. Historialité de la fatigue

1.3.2.1. Le temporel

1.3.2.2. L'historial

1.4. Phénoménologie clinique de la fatigue

1.4.1. La fatigue physique sans épuisement psychique

1.4.2. Le paradigme de la fatigue psychogène : l'acédie

Dépression vraie versus paradépression

Le champ paradépressif et la fatigue psychogène

L'acédie monastique, le "démon de midi"

Orientations thérapeutiques

1.4.3. Les réactions abandonniques

1.4.4. Fatigue ou inhibition dans la dépression mélancolique

1.4.5. Luttres anxieuses et ruminations : les deux formes de l'asthénie

1.5. Synthèse clinique et phénoménologique

II. EXISTER, HABITER

2.1. Introduction

2.1.1. Articulations cliniques

2.1.2. Usages professionnels et lieux d'exercice

Gériatrie et gériatologie

Psychiatrie et santé mentale

Cadres sociaux et médicaux-sociaux

Addictologie

Réadaptation et rééducation

Médecine du travail, pathologies professionnelles

Accompagnement post-traumatique

Soins à domicile et soins ambulatoires

Protection de l'enfance et parentalité

Étudiants, écoles

Justice, pénitentiaire, réinsertion

Principes transversaux de l'intervention

2.2. Phénoménologie du quotidien

2.2.1. *L'énigme du familier*

Le double visage du quotidien

Le « Lebenswelt »

2.2.2. *Le quotidien comme structure de l'expérience*

Les structures fondamentales du monde quotidien

L'équilibre familier / étranger

La spatialité quotidienne : un espace domestiqué

La temporalité quotidienne : rythme, répétition, routine

La socialité quotidienne

Intercorporéité

Interactions, rôles

Normativité : le permis et le possible

2.2.3. *Le processus de « quotidianisation »*

Le quotidien comme « construit »

L'habitude

La genèse « socio-transcendantale » du quotidien

2.2.4. *Clinique du quotidien*

Le monde quotidien comme fond de toute santé psychique

Les dérèglements de la quotidienneté

Phénoménologie du « bien-être »/« mal-être »

Repenser le bien-être au-delà de la satisfaction

Le quotidien comme condition ontologique du bien-être

Les dimensions relationnelles

Bien-être et ouverture à l'étrangeté

Psychopathologie du quotidien

La dépression : effondrement de la familiarité

Les troubles obsessionnels-compulsifs : hypertrophie du quotidien

La schizophrénie : étrangeté du quotidien

L'anxiété : menace diffuse dans le quotidien

Le soin comme « re-quotidianisation »

2.3. Phénoménologie de l'habiter

2.3.1. *Origines de la réflexion*

Heidegger : « Bâtir Habiter Penser »

Bachelard : la « Poétique de l'espace »

Bollnow : « L'homme et l'espace »

Merleau-Ponty : la « chair du monde »

Hoyaux « géographie et phénoménologie »

2.3.2. *L'habiter comme structure existentielle*

L'habiter comme mode d'être

La structure tripolaire de l'habiter

Le corps comme condition de possibilité de l'habiter

Seuils, frontières et rythmes

L'habiter comme processus de familiarisation

Atmosphères et dimension pathique de l'espace

Dimensions intersubjectives de l'habiter

Figures existentielles de l'habiter

Habiter, quotidien et bien-être

2.3.3. Psychopathologie de l'habiter

L'agoraphobie : rupture de la familiarité spatiale

La claustrophobie : enfermement spatial

La dépression : délabrement de l'espace habité

La schizophrénie : désarticulation de l'espace vécu

L'addiction : rétrécissement de l'espace vital

Le traumatisme : hantise des lieux

2.3.4. Habiter, (se) territorialiser : le « Soi territorial » et l'habitation du corps

Genèse du territoire : du corps au monde

Les strates de territorialisation : du corps à l'espace habité

Le « Soi territorial »

Les pratiques quotidiennes de territorialisation

Territorialisation et déterritorialisation

Implications thérapeutiques et professionnelles

I. Phénoménologie de la fatigue et clinique de la dépression

Introduction

1.1. Les « sentiments corporels »

Granger Bernard, Charbonneau Georges (dir.), *Phénoménologie des sentiments corporels, tome 2.*

Fatigue, lassitude, ennui, Argenteuil, Le Cercle herméneutique, 2003.

Carrique Pierre, (dir.), *Phénoménologie des sentiments corporels, tome 3. Joie, jouissance, ivresses,*

Argenteuil, Le Cercle herméneutique, 2010.

1.1.1. Définition et spécificité

Sur la notion de "sentiment corporel" :

Sentiment corporel et "disposition"

Sentiment corporel et sentiment (général)

1.1.2. Le pré-sensoriel et le sensoriel

Une "pré-expérience du monde" ou "expérience pré-sensorielle"

Les sentiments corporels sont aprioriques :

. ils précèdent l'expérience

. ils déterminent un pouvoir d'action

les sentiments corporels sont autant conscients qu'inconscients

1.2. Vécus de fatigue

Vécus de fatigues *versus* douleurs musculaires

Ambivalence sensorielle du vécu de fatigue : entre plaisir et déplaisir

Distinction entre fatigue (comme sentiment corporel) et états thymiques

La fatigue au regard de l'opposition conscient / inconscient

1.2.1. Le « vécu de pouvoir »

Relations du "je peux" et de l'espace

Le "Je peux" est un organisateur temporel autant que spatial.

Le vécu de pouvoir-être abolit la pesanteur du monde.

La fatigue comme abandon du pouvoir-être

Etre vivant, phénoménologiquement = déployer du possible

Le « je peux » = une « conscience corporelle » immédiate du possible

1.2.2. Le « vécu de valoir »

Alteration du vécu de valoir : une "dédiérenciation du monde"

« impression vitale » : "cela vaut" + "je peux"

"nihilisme" : abolition du vécu de valoir

1.3. Fatigue et épuisement

1.3.1. Sémiologie différentielle

Fatigue *versus* épuisement

Aspect temporel de la fatigue :

- pas d'altération des qualités du monde
- cette fatigue est "endurée"

La transformation de la fatigue en épuisement

> la fatigue est temporelle / l'épuisement est historial

Dimension	Fatigue	Mélancolie / Dépression
Temporalité	Temporelle (présent étiré, futur peu libérateur)	Altérée (futur fermé, passé envahissant)
Rapport au monde	Monde encore « normal », sensible, habitable	Monde dévalué, ou vidé de sens
Rapport à soi	On s'endure, on supporte le présent	On se juge, on se sent coupable ou fautif
Affect dominant	Endurance, pesanteur, lenteur	Culpabilité, désespoir, perte de valeur

1.3.2. Historialité de la fatigue

Le *temporel* (entre passé et avenir) et l'*historial* (entre début et fin) :

Le temporel = une structure identique à elle-même ("linéaire") du présent dans sa relation au passé et au présent

1.3.2.1. Le temporel

L'exemple de la mélancolie :

- . historial : un cycle de "vitalité"

1.3.2.2. L'historial

- . le commencement
- . la maturation
- . la densification
- . la saturation

Les pathologies de l'historialité :

- . le recommencement impossible
- . le recommencement permanent

L'épuisement est "historial" : un sentiment de fin

Le soupir : expression d'un "trop-plein intérieur"

De la fatigue à l'épuisement

De l'épuisement à l'abandon

1.4. Phénoménologie clinique de la fatigue

Les "vraies" et les "fausses" fatigues

Cinq « vécus de fatigue » :

- . la pure fatigue physique
- . les réactions d'abandon
- . la fatigue psychogène non dépressive

- . le sentiment corporel dépressif
- . les fatigues de rumination (psychasthénie/névrose obsessionnelle)

1.4.1. La fatigue physique sans épuisement psychique

L'affectation isolée du *vécu de pouvoir* est le propre de la fatigue physique.

Evolution possible d'allure dépressive

1.4.2. Le paradigme de la fatigue psychogène : l'acédie

Deux formes de fatigue :

- La *fatigue psychogène* : affecte la *valeur* du monde et du sens de nos actes
- La fatigue liée au "*vécu de pouvoir*" : valeur du monde intacte, mais atteinte de la capacité d'agir

Dépression vraie versus paradépression

Distinction entre paradépression et dépression vraie (mélancolique) :

- paradépression : la valeur des actes est affaiblie ; on ne voit plus le sens de ce qu'on fait
- dépression vraie : les valeurs sont maintenues ; le sujet ne peut plus les porter
 - . tout garde un sens grave
 - = un excès de sens moral : la personne est accablée par le poids de la faute (ni ennui, ni cynisme)

Le champ paradépressif et la fatigue psychogène

« *A quoi bon ?* » : paradépression, un état à mi-chemin entre le phénoménologique (le vécu du sens) et le psychologique

« *Rien ne vaut plus rien !* » : dépression vraie, mélancolie

L'acédie monastique, le "démon de midi"

Variations cliniques :

Critères	Fatigue (psychogène)	Paradépression	Acédie	Dépression ("vraie") mélancolique
Définition / Essence	État de saturation du vécu ; trop-plein de "même", lassitude intérieure.	État intermédiaire entre normalité et dépression ; perte partielle de la valeur des choses.	Forme ancienne de la paradépression, décrite chez les moines ; "démon du midi".	Effondrement moral profond ; "gravité du sens" insoutenable.
Rapport au sens / à la valeur	Le monde garde sa valeur, mais elle est obscurcie par la saturation.	Dévaluation sélective : certaines choses ne "valent plus rien" → début de nihilisme.	Altération du rapport spirituel au monde : perte du sens du travail, du devoir, du divin.	Le sens est trop fort : le monde est lourd de valeur et de gravité morale.
Rapport à l'action / à la motivation	Perte momentanée d'élan, besoin de repos ou de recommencement.	Motivation affaiblie, dépendante du désir immédiat ; tout est marqué d'un "à quoi bon".	Tentation de l'inaction, de la distraction, de l'oisiveté ; renoncement à l'effort spirituel.	L'action devient impossible : sentiment d'indignité, de faute, d'échec.
État affectif dominant	Lassitude, soupir, saturation.	Ennui, découragement, désintérêt.	Découragement, apathie, indifférence.	Douleur morale, culpabilité, gravité.
Réversibilité	Réversible par	Réversible : un	Réversible par la	Non réversible sans

	repos, fin ou nouveauté.	événement ou une stimulation peut raviver l'énergie.	reprise du sens, du travail ou de la prière.	aide : aucune stimulation ne réanime le sujet.
Exemple typique	Le soupir d'épuisement sans désespoir.	Personne lassée qui retrouve de l'énergie dès qu'un plaisir survient.	Religieux lassé, tenté par l'inaction spirituelle.	Le mélancolique est accablé par un devoir ou une faute qu'il ne peut assumer.

Synthèse :

- Fatigue → surcharge, besoin de pause
- Paradépression → perte partielle du sens, ennui, "à quoi bon"
- Acédie → ancienne figure de la paradépression : fatigue spirituelle et morale
- Mélancolie → excès de sens, gravité morale insoutenable, non-nihiliste

Orientations thérapeutiques

1.4.3. Les réactions abandonniques

- fatigue simple : besoin de repos après un effort
- abandonnisme : réaction pathologique, anticipation de la fin avant achèvement de l'action

1.4.4. Fatigue ou inhibition dans la dépression mélancolique

Tristesse vs mélancolie :

- La mélancolie n'éprouve pas la fatigue comme telle : il n'y a ni fatigue, ni tristesse : seulement la gravité absolue d'un monde clos
- La tristesse suppose encore un monde partagé, et une valeur reconnue

Tableau de synthèse : Mélancolie vs fatigue / tristesse

Critères	Fatigue	Tristesse	Mélancolie
Nature du vécu	Lassitude, saturation, besoin de repos.	Douleur affective liée à une perte ou une déception.	Saisissement total, gravité morale, sentiment de faute.
Rapport au temps	Orientée vers le futur : "je pourrai me reposer, recommencer".	Inscrite dans le présent : "je perds quelque chose qui comptait".	Tournée vers le passé : "tout est déjà fini, trop tard".
Rapport à l'action	Action suspendue mais possible.	Action ralentie, réflexive.	Inhibition totale : le pouvoir d'agir est bloqué dans la faute.
Rapport au monde	Monde encore ouvert, disponible.	Monde commun, partagé et nuancé.	Monde fermé, monolithique, sans distance ni ouverture.
Plainte du sujet	"Je suis fatigué, je ne peux plus."	"Je suis triste, j'ai perdu quelque chose."	(Silence, sidération) : "Je suis coupable, indigne, il est trop tard."
Symptôme corporel dominant	Sensation de lourdeur, besoin de repos.	Pleurs, perte d'élan affectif.	Inhibition psychomotrice d'inutilité.
Sens dominant	Trop de même, saturation du présent.	Déception, perte de valeur.	Faute irréparable, dette infinie.

En résumé :

- La fatigue → encore orientée vers l'avenir (besoin de repos)
- La tristesse → douleur du présent (perte de valeur)
- La mélancolie → enfermement dans le passé (impossibilité de rachat)

1.4.5. Luttres anxieuses et ruminations : les deux formes de l'asthénie

L'effet d'activité compulsives

Une énergie de distanciation sans finalité

Une fatigue de rumination : la psychasthénie

Un effort permanent de « tenir le monde à distance »

Une fatigue de « remondéisation » (reconstituer un monde cohérent)

Une « fatigue ontologique »

Synthèse : les fatigues asthéniques (obsessionnelle et sensitive) :

Critères	Asthénie obsessionnelle	Asthénie/fatigue sensitive
Structure clinique	Névrose obsessionnelle, rigidité, surmoi exigeant.	Personnalité sensitive, honte, peur d'exclusion.
Mécanisme	Lutte contre le désordre organique ; besoin de pureté et de maîtrise.	Lutte contre la proximité et la gêne ; besoin de distance sécurisante.
Énergie mobilisée	Énergie de conjuration et de recomposition symbolique.	Énergie de retrait et de protection identitaire (défense du moi).
But inconscient	Maintenir un monde stable, non vivant, "minéral".	Préserver le soi menacé par la honte ou la fusion.
Symptômes	Tension, lourdeur, ritualisation, rigidité comportementale, tensions.	Gêne, fatigue nerveuse, inhibition, honte latente, sensation de "trop-près".
Rapport au monde	Monde vécu comme menacé par le vivant, par le désordre.	Monde vécu comme trop proche, intrusif, indiscret.
Rapport à soi	Moi en lutte contre les pulsions et le vivant.	Moi fragile, craignant le dévoilement et l'exclusion.
Forme de fatigue	Fatigue d'ordre et de propreté ; épuisement du contrôle. Fatigue de lutte contre le vivant	Fatigue d'existence et de défense du soi ; fatigue d'être exclu ou trop proche
Proximité phénoménologique	Fatigue du contrôle → angoisse d'impureté.	Fatigue de la gêne → angoisse du dévoilement.
Finalité du travail intérieur	Recomposition constante du monde symbolique.	Préservation d'une distance existentielle respirable.
Essence	Fatigue de conjuration du désordre.	Fatigue de conjuration de la honte et de la proximité.
Résultat	Epuisement d'un ordre toujours à reconstruire	Epuisement d'une distance toujours à maintenir
Niveau ontologique	Épuisement du monde : lutte contre la prolifération du vivant.	Épuisement de soi : lutte contre l'exposition et la dissolution.

1.5. Synthèse clinique et phénoménologique

- Fatigue physique : atteinte du pouvoir, pas du sens
- Fatigue psychogène : atteinte du sens avant du pouvoir
- Épuisement : sentiment de fin et d'historialité
- Mélancolie : pas de fatigue, mais inhibition du pouvoir-être

Importance clinique et existentielle :

> Le corps, le sens, le temps et la valeur ne s'épuisent pas de la même manière :

Les niveaux d'atteinte :

Forme de vécu	Dimension atteinte	Rapport au sens ("cela vaut")	Rapport au pouvoir ("je peux")	Temporalité vécue	Figure clinique
Fatigue physique	Corporelle	Intacte : le monde garde sa valeur.	Atteinte : effort, besoin de repos.	Présent orienté vers le futur (repos possible).	Randonneur épuisé mais motivé.
Fatigue psychogène	Affective / existentielle	Altérée : perte du "cela vaut".	Diminuée secondairement.	Présent suspendu, attente, ennui.	Paradépression, acédie.
Épuisement historial	Temporel / historique	Sens en voie d'extinction.	Pouvoir dissout, sentiment de fin.	Temps de la terminaison, vespéral.	Lassitude du monde.

Forme de vécu	Dimension atteinte	Rapport au sens ("cela vaut")	Rapport au pouvoir ("je peux")	Temporalité vécue	Figure clinique
Mélancolie	Psychotique / morale	Excès de sens, dette infinie.	Inhibition totale du pouvoir-être.	Temps inversé vers le passé, culpabilité.	Mélancolique tétanisé, faute irréparable.

- évite de confondre des phénomènes différents

- permet de ne pas médicaliser > travail psychothérapeutique sur le sens et la valeur

- rappelle le rapport fondamental au monde : effectif et pratique, fondé sur un double originaire :

Synthèse clinique et existentielle des formes de lassitude, d'épuisement et d'effondrement - de la fatigue simple à la mélancolie, en passant par la paradépression, l'acédie, l'abandonnisme, et les fatigues asthéniques (obsessionnelle et sensitive) :

Catégorie	Essence / Définition	Rapport au sens	Rapport à l'action	Affect dominant	Profil / Structure	Réversibilité / Issue
Fatigue psychogène	Surcharge du vécu, saturation, besoin de repos.	Le sens demeure, mais obscurci.	L'action continue mais réclame une pause ou un recommencement.	Lassitude, soupir.	Sujet stable, simplement épuisé.	✅ Oui – par repos, pause, nouveauté.
Paradépression	Perte partielle du sens, vide de motivation.	Dévaluation sélective, "à quoi bon".	Action automatique ou suspendue ; dépend du désir immédiat.	Ennui, désintérêt, vide.	Sujet vulnérable, dépendant du plaisir.	✅ Oui – par rencontre, relance existentielle.
Acédie	Découragement spirituel, lassitude morale.	Perte du sens du travail ou du divin.	Tentation de l'inaction, oisiveté.	Découragement, apathie.	Sujet spirituel, moralement épuisé.	✅ Oui – par reprise du sens et du devoir.
Abandonnisme	Laisser-aller pathologique, anticipation de la fin.	Sens effacé par peur de l'échec.	Action interrompue avant son terme.	Peur, honte, renoncement.	Sujet fragile, phobique, hystérique.	⚠ Difficile – nécessite soutien relationnel.
Dépression mélancolique	Effondrement moral et temporel ; noyau psychotique.	Excès de sens, dette morale infinie.	Inhibition totale : pouvoir d'agir bloqué dans la faute.	Culpabilité, gravité, désespoir.	Sujet mélancolique, enfermé dans le passé.	❌ Non sans traitement médical.
Asthénie obsessionnelle	Fatigue du contrôle, épuisement de la pureté.	Sens menacé par le désordre du vivant.	Activité rituelle et défensive, lutte contre le désordre.	Tension, lourdeur, contrainte.	Névrose obsessionnelle, surmoi tyrannique.	⚠ Partielle – allègement du contrôle, psychothérapie.
Asthénie sensitive	Fatigue de la gêne et de la honte.	Sens menacé par la proximité d'autrui.	Retrait, inhibition, défense contre l'exposition.	Gêne, honte, hypervigilance.	Structure sensitive, crainte d'exclusion.	⚠ Partielle – travail de confiance et d'ipséité.

II. Exister, habiter

2.1. Introduction

2.1.1. Articulations cliniques

Premier axe - Phénoménologie du quotidien

Deuxième axe - Phénoménologie de l'habiter

Troisième axe - Bien-être et mal-être / santé psychique

Articulations conceptuelles : familiarité et étrangeté

2.1.2. Usages professionnels et lieux d'exercice

Compétences patho-cliniques pertinentes pour :

- les situations intermédiaires (entre normal et pathologique lourd)
- le mal-être ordinaire et la souffrance diffuse
- les transitions de vie (déménagement, entrée en institution, perte d'autonomie)
- les pathologies chroniques nécessitant une réorganisation existentielle

> Accompagnement/rétablissement versus "traitement" :

- dimension écologique de la santé psychique
- co-construction du sens avec la personne
- restauration de la « confiance ontologique » vs suppression de symptômes
- accompagnement plutôt que "correction"

Gériatrie et gérontologie

Institutions et associations (sanitaires et médico-sociales) :

- EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
- USLD (Unités de Soins de Longue Durée)
- Résidences autonomie (ex foyers-logements)
- Accueils de jour
- SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile)
- UCC – Unités Cognitivo-Comportementales (troubles du comportement sévères)
- Plateformes de répit (soutien aux aidants)
- SAAD – Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
- Soins palliatifs (unités ou équipes mobiles)

Enjeux cliniques :

- Transition résidentielle : perte du « chez-soi habituel » + nécessité de familiariser un nouvel espace
- Désorganisation temporo-spatiale : troubles cognitifs affectant simultanément les routines et le repérage spatial
- Perte d'autonomie : difficulté dans les gestes quotidiens + transformation du rapport à l'espace domestique

Contextes d'interventions :

- L'hébergement vécu comme exil possible

- Maintien des routines personnelles (horaires de lever, rituels du matin)
- Personnalisation de l'espace (chambre avec objets familiers)
- Création de repères spatio-temporels (calendrier, organisation spatiale claire)
- Accompagnement de la familiarisation progressive avec les lieux collectifs
- Travail sur les seuils (porte de chambre, couloir, salle commune)
- Appropriation symbolique (objets, photos, odeurs) et pas seulement fonctionnelle

Psychiatrie et santé mentale

Institutions (voir hôpitaux et centres de soins associatifs) :

- Hôpitaux psychiatriques (services d'hospitalisation complète)
- Hôpitaux de jour psychiatriques
- CMP (Centres Médico-Psychologiques)
- CATTP (Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel)
- CSAPA (Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie)
- Appartements thérapeutiques
- Centres de post-cure
- ACT – Appartements de Coordination Thérapeutique
- Équipes mobiles psychiatrie-précarité
- Clubs thérapeutiques

Enjeux cliniques :

- Accompagnement vers le logement autonome : routines + familiarisation spatiale
- Capacité à s'installer (se poser, rester, revenir)

Cadres d'interventions :

- Ateliers de réhabilitation psychosociale : gestes quotidiens (cuisine, entretien) et aménagement d'espace
- Groupes de médiation/médiateur en santé mentale : structuration temporelle et appropriation de lieux partagés
- Micro-structures du quotidien (petits possibles, rendez-vous-rituels)
- Art-thérapie, ergothérapie : travail sur le corps vécu, l'espace, les rythmes
- Travailleurs pairs
- Médiateurs en santé mentale
- Conseillers en insertion
- Parcours de rétablissement

Cadres sociaux et médicaux-sociaux

Institutions pour l'hébergement et l'insertion :

- CHRS (Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale)
- CHU (Centres d'Hébergement d'Urgence)
- Maisons relais / Pensions de famille
- Centres maternels
- Foyers de jeunes travailleurs
- CADA (Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile)

- Foyers d'accueil médicalisés (FAM)
- Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS)
- Associations type "*Un chez-soi d'abord*"
- Médiation sociale, pair-aidance

Contextes spécifiques :

- Absence de "chez-soi" : pas de routines stables + déracinement spatial
- Précarité : quotidien chaotique et errance spatiale
- Migration/exil : perte des repères culturels quotidiens + déterritorialisation complète
- Handicap : difficultés dans les actes de la vie quotidienne + besoin d'adaptation spatiale

Contextes d'interventions :

- Création de repères minimaux (horaires de repas, lieu personnel)
- Ritualisation sécurisante : moments réguliers, espaces identifiés
- Accompagnement de la réappropriation : "faire sien" un espace temporaire
- Travail sur la projection : imaginer un futur quotidien et spatial stable

Addictologie

Institutions :

- CSAPA – Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (déjà cités)
- CAARUD – Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues
- LHSS – Lits Halte Soins Santé
- ACT – Appartements de Coordination Thérapeutique
- Communautés thérapeutiques

Apport conceptuel spécifique :

- L'addiction comme rétrécissement spatio-temporel du monde
- Notion de lieux à risque / lieux ressources
- Le "chez-soi" comme espace ambivalent (protection / tentation)

Réadaptation et rééducation

Institutions :

- SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
- Centres de rééducation fonctionnelle
- Services d'ergothérapie
- Unités neuro-vasculaires
- Centres de rééducation neurologique
- IME – Instituts Médico-Éducatifs
- SESSAD – Services d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
- SAMSAH – Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
- SAVS – Services d'Accompagnement à la Vie Sociale
- Plateformes TSA – Troubles du Spectre de l'Autisme

Enjeux cliniques :

- Perte de capacités physiques : impossibilité d'accomplir les gestes quotidiens + transformation du rapport au corps et à l'espace
- Maladie chronique : réorganisation complète du quotidien ET adaptation de l'habitat
- AVC, traumatismes : réapprentissage des routines + modification du schéma corporel et spatial

Contextes d'interventions :

- Réentraînement aux activités de la vie quotidienne, reconstruction des continuités
- Adaptation de l'environnement : aménagement du domicile
- Reconstruction du schéma corporel dans l'espace vécu
- Notion de centre / dedans : absence de seuil, d'intimité (déracinement spatial, déterritorialisation)
- Accompagnement du retour à domicile : anticipation des nouvelles routines dans l'espace transformé
- Notions d'affordances, d'atmosphères, de sensorialité

Médecine du travail, pathologies professionnelles

Institutions :

- Services de santé au travail
- Consultations souffrance au travail
- Réseaux de prévention du burn-out
- Cellules d'accompagnement professionnel

Enjeux cliniques :

- Envahissement du quotidien par le travail : disparition des rythmes personnels + réduction de l'espace vital au bureau/travail
- Épuisement professionnel : perte des routines de récupération + impossibilité de "rentrer chez soi" psychologiquement
- Souffrance éthique : désajustement entre valeurs et pratiques quotidiennes
- Transition professionnelle (ex. "transition agro-écologique")

Cadres et objectifs des interventions :

- Restauration de frontières temporelles (travail/hors-travail)
- Réinvestissement de l'espace domestique comme lieu de ressourcement
- Reconstruction de rythmes protecteurs

Accompagnement post-traumatique

Institutions :

- Cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP)
- Centres de psychotraumatologie
- Unités victimologie
- Associations d'aide aux victimes

Enjeux cliniques :

- Hantise des lieux : certains espaces deviennent inhabitables
- Rupture du quotidien : impossibilité de reprendre les routines d'avant
- Hypervigilance : le familial (spatial et temporel) devient menaçant
- Intrusions : envahissement du quotidien et les lieux actuels par le passé traumatique

Cadres de l'intervention :

- Sécurisation de l'espace thérapeutique (stabilité du lieu, du cadre)
- Reconstruction narrative : réintégrer l'événement dans l'histoire de vie
- Réappropriation progressive des lieux et des routines
- Travail sur la confiance dans le monde (quotidien et spatial)

Soins à domiciles et soins ambulatoires

Institutions, associations :

- Cabinets libéraux (psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens)
- SSIAD, SPASAD (Services Polyvalents d'Aide et de Soins à Domicile)
- HAD (Hospitalisation à Domicile)
- Services d'aide à domicile
- Consultations CMP

Enjeux cliniques :

- Maintien à domicile : préservation des routines dans l'espace familial menacé
- Soutien aux patients et aidants : préservation de leur propre quotidien et espace
- Isolement : quotidien appauvri + rétrécissement de l'espace vécu
- Vieillesse : adaptation progressive du quotidien et de l'habitat

Protection de l'enfance et parentalité

Institutions :

- PMI – Protection Maternelle et Infantile
- ASE – Aide Sociale à l'Enfance
- AEMO – Action Éducative en Milieu Ouvert
- MECS – Maisons d'Enfants à Caractère Social

Apport spécifique :

- Le quotidien comme lieu central de la parentalité
- L'habiter comme condition de sécurité psychique de l'enfant

Étudiants, écoles

Institutions :

- BAPU – Bureaux d'Aide Psychologique Universitaires
- Services de santé universitaire
- Internats, dispositifs handicap

Clinique :

- Désorganisation du temps
- Difficulté à habiter un lieu étranger (chambre, colocation, campus)

Justice, pénitentiaire, réinsertion

Institutions :

- SPIP – Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation
- Milieu carcéral, semi-liberté, post-détention

Apport clinique :

- Transition d’un quotidien hyper-normé → quotidien à reconstruire
- Habiter des lieux parfois toxiques ou inconnus

Principes transversaux de l'intervention

Le quotidien et l’habiter sont des *organismes cliniques*

Le soin s'appréhende comme "re-quotidianisation" et « rétablissement » :

- restaurer la familiarité
- reconstruire la temporalité
- réancrer spatialement
- restaurer l'intersubjectivité, etc.

2.2. Phénoménologie du quotidien

Le plus visible est invisible !

2.2.1. L'énigme du familier

Le quotidien : tout et rien

Est quotidien tout ce qui, dans notre environnement, nous est immédiatement accessible, compréhensible et familier par sa régularité.

Un mode de manifestation, caractérisé par :

- la répétition temporelle
- la familiarité spatiale
- la proximité pratique

Un monde « pré-donné »

Le double visage du quotidien

L'idéologie de la « valeur refuge »

Le « Lebenswelt »

Husserl : la matrice phénoménologique du quotidien

La découverte du « monde de la vie » (*Lebenswelt*)

Husserl Edmond, *La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale* (1935), Paris, Gallimard, 2004.

Le renversement de la crise de la science :

La structure du *Lebenswelt* :

- pré-théorique
- intersubjectif
- pratique
- routinier
- évident

Le « garant horizontal » de la vérité

2.2.2. Le quotidien comme structure de l'expérience

La familiarité pré-réflexive et l'« évidence naturelle »

Concepts clés :

- Le monde ambiant (Heidegger)
- L'attitude naturelle (Husserl) :
- Le schéma corporel (Merleau-Ponty)
- > une ontologie du quotidien

Bégout Bruce, « L'ontologie husserlienne du monde de la vie quotidienne », dans Jocelyn Benoist, Bruno Karsenti, *Phénoménologie et sociologie*, Paris, PUF, 2001, p. 83-104.

Bégout Bruce, *La découverte du quotidien*, Paris, Allia, 2005.

Les structures fondamentales du monde quotidien ***L'équilibre familier / étranger***

L'étrangeté inexpugnable : imprévus, anomalies, crises, situations limites...

Le quotidien : un mouvement d'équilibre en tension avec le "réel" (C. Dejours)

Lieux et temps de la souffrance

L'unité dynamique du monde quotidien

La spatialité quotidienne : un espace domestiqué

Une géographie du familier - une structure d'horizon :

- espace proche
- espace ordonné
- espace hiérarchisé

La temporalité quotidienne : rythme, répétition, routine

Un temps rythmé par :

- les habitudes
- les rythmes et cycles
- les obligations

Des temporalités différentes :

- temps de la nécessité
- temps choisi
- temps flottant

La socialité quotidienne

Intercorporéité

Interactions, rôles

- les relations familiales, professionnelles, amicales
- les codes sociaux, rituels
- le langage ordinaire
- les rôles « typifiés »

Schütz Alfred, *Essais sur le monde ordinaire*, Editions du Félin, 2010.

Schütz Alfred, *Éléments de sociologie phénoménologique*, L'Harmattan, Paris, 2014.

Perreau Laurent, « Alfred Schütz et le problème du monde de la vie », *Philosophie*, n° 108, 2011/1, p. 35-54.

Tellier Frédéric, *Alfred Schütz et le projet d'une sociologie phénoménologique*, Paris, PUF, 2003.

Normativité : le permis et le possible

Un régime de régularité normative :

- normes pratiques
- les normes de métier
- normes morales

Quotidienneté et confiance ontologique

2.2.3. Le processus de « quotidianisation »

Le quotidien comme « construit »

Le quotidien n'est pas un « donné », mais un « construit »

« Nous nommons quotidianisation ce processus d'aménagement matériel du monde incertain en un milieu fréquentable, ce travail de dépassement de la misère originelle de notre condition par

la création de formes de vie familiales. » (Bégout, op. cit. p. 225).

L'habitude

« S'il n'y avait pas l'habitude, la vie devrait paraître délicieuse à des êtres qui seraient à chaque heure menacée de mourir – c'est-à-dire à tous les hommes » (Proust, *A l'ombre des jeunes filles en fleurs*, vol. II, p. 73, cité par B. Bégout, *La découverte du quotidien*, Paris, Allia, 2005, p. 313)

« Sans l'habitude, c'est-à-dire la quotidienneté, l'expérience du monde se déroulerait dans une atmosphère ambiguë de découvertes et d'agressions, d'attirance et de répulsion. Comme au premier jour, tout serait incertain, et par cela sans doute excitant et assurément inquiétant. L'illimité gouvernerait toutes choses. » (Bégout 2005), situation favorable au mal-être, voire à l'angoisse.

La genèse « socio-transcendantale » du quotidien

Une « genèse socio-transcendantale » entre :

- l'analyse transcendantale des structures a priori de l'expérience du monde
- l'analyse sociologique des pratiques, institutions et habitudes

Finalité : produire un monde sûr et vivable

< Le processus de quotidianisation a pour [seule et unique] finalité de produire un monde sûr et hospitalier. Il y parvient en modelant l'espace, le temps et la causalité selon les critères de la sécurité et de la familiarité (...). Il faut dès lors concevoir la genèse passive du monde quotidien comme cette création de formes de vie qui, recouvrant l'abîme originel, objectivent l'existence humaine dans des manières de vivre, des territoires et des lois, des objets et des attitudes particuliers. Ni innées ni a priori, ces structures générales du monde quotidien découlent seulement du processus de quotidianisation. Elles représentent son résultat formel. » (Bégout, op. cit. p. 319).

Car la familiarisation ne produit pas simplement une croyance spécifique –
l'évidence naturelle – elle engendre aussi des formes de vie tout à fait spécifique.

« Heidegger souligne que cette préposition [in dans In-Sein [in-der-Welt-sein]] provient en allemand du verbe innan qui signifie habiter [Sein und Zeit, Tübingen, Niemayer, 1927, p. 54] C'est cette Vertrautheit, cette familiarité ou cette confiance, qui constitue le phénomène originaire de la quotidienneté. » (F. Dastur, « Heidegger espace, lieu, habitation », *Les Temps Modernes*, n° 650, 2008/4, p. 142).

< Dans son rapport au monde, dans sa préoccupation, le Dasein, à la différence du sujet classique, n'a pas affaire à des "objets" isolés et situés "dans" l'espace, mais à un complexe d'outils liés entre eux par des réseaux de renvois à travers lesquels il se signifie à lui-même son propre être dans le monde. » Ce à quoi le Dasein est donc de prime abord ouvert, ce n'est pas à la réalité matérielle et sensible en tant que telle, mais à la signification qu'elle revêt pour lui, à un environnement, un Umwelt, dont il fait lui-même partie, puisqu'il en constitue la "finalité" dernière.

« La quotidianisation ne vit que ce de qui la contrarie. A défaut de pouvoir assimiler les multiples données inconnues qui apparaissent constamment à ses frontières (et que chaque impression nouvelle contient en puissance), la domestication familière dépérirait en une vie morose, sclérosée, ossifiée, une vie moins qu'ordinaire. » (Bégout 2005).

La structure la plus fondamentale : transformation de l'inconnu en familier, par :

- la répétition
- l'appropriation
- la domestication
- la sédimentation

2.2.4. Clinique du quotidien

Le monde quotidien comme fond de toute santé psychique

Le « monde de la vie » est la condition de la normalité existentielle

Les dérèglements de la quotidienneté

La quotidienneté comme « structure de la normalité existentielle »

L'ambivalence du quotidien

La clinique de l'ordinaire

Phénoménologie du « bien-être »/« mal-être »

Repenser le bien-être au-delà de la satisfaction

Définitions du bien-être dans les psychologies classiques/comportementales :

- réduction du stress
- satisfaction des besoins
- maximisation des affects positifs, etc.

versus Perspective phénoménologique :

- fluidité de l'expérience
- présence pleine
- ouverture temporelle
- accordage affectif
- légèreté ontologique
- capacité d'être affecté
- acceptation de l'ambiguïté
- enracinement

Le quotidien comme condition ontologique du bien-être

Le "bien-être" comme « être-bien-dans-le-monde »

La forme affective du monde quotidien intact

Le bien-être comme « confiance dans la familiarité du monde »

Ecologie du bien-être : un milieu, plutôt qu'un état intérieur

Les dimensions relationnelles

- reconnaissance mutuelle
- intercorporéité "harmonieuse"
- sentiment d'appartenance

Bien-être et ouverture à l'étrangeté

Psychopathologie du quotidien

La dépression : effondrement de la familiarité

Les troubles obsessionnels-compulsifs : hypertrophie du quotidien
La schizophrénie : étrangeté du quotidien
L'anxiété : menace diffuse dans le quotidien

Le soin comme « re-quotidianisation »

La quotidienneté comme outil clinique *et* enjeu thérapeutique

Renouvellement de la compréhension du bien-être

En résumé :

Dimension	Application au « bien-être »
Ontologique	Bien-être = accord tacite avec le monde (le monde quotidien comme sol d'évidence)
Phénoménologique	Bien-être = fluidité du vécu, confiance implicite, familiarité, habitude, continuité
Éthique	Bien-être = équilibre entre stabilité et ouverture, familiarité et étrangeté (refus du refuge anesthésiant)
Clinique	Mal-être = rupture du quotidien, affaissement/effondrement de l'évidence
Thérapeutique	Soin = rétablissement de la continuité et du rythme du monde vécu > « re-quotidianisation » du monde

2.3. Phénoménologie de l'habiter

« Regarder un objet, c'est venir l'habiter » (M. Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, p. 82)

2.3.1. Origines de la réflexion

Heidegger : « Bâtir Habiter Penser »

Exister, c'est « habiter le monde »

Heidegger Martin, « Bauen Wohnen Denken » [1951], *Gesamtausgabe, I Abteilung : Veröffentlichte Schriften 1910- 1976, Band 7 Vorträge und Aufsätze*, Frankfurt/Main, Vittorio Klostermann, 2000, p 145-164.

Heidegger Martin, « Bâtir habiter penser », *Essais et conférences*, Paris, Gallimard, coll. "Tel", 2001, p. 170-193.

Bachelard : la « Poétique de l'espace »

Bachelard Gaston, *La poétique de l'espace*, Paris, PUF, 1961

- la maison comme cosmos premier
- la « topophilie »
- la dialectique du dedans et du dehors
- la verticalité de la maison : une « architecture psychique » :

Bollnow : « L'homme et l'espace »

Bollnow Otto Friedrich, *Mensch und Raum. Schriften Band VI* [1963], Würzburg, Königshausen & Neumann, 2011.

trad. anglaise : *Human Space*, London, Hyphen Press, 2011.

- l'espace « hodologique »
- l'organisation centres/périphéries
- les humeurs spatiales

Merleau-Ponty : la « chair du monde »

Merleau-Ponty Maurice, *Le Visible et l'invisible* [1964], Paris, Gallimard, coll. "Tel", 1979.

- l'incorporation du lieu
- la réversibilité corps-monde
- le lieu comme "style"

Hoyaux « géographie et phénoménologie »

Hoyaux André-Frédéric, « Géographie et phénoménologie : perspectives théoriques et méthodologiques autour de la proximité et de l'authenticité », dans Bruno Frère, Sébastien Laoureux (dir.), *La phénoménologie à l'épreuve des sciences humaines*, P.I.E. Peter Lang, pp.73-88, 2013.

Hoyaux André-Frédéric, « Entre construction territoriale et constitution ontologique de l'habitant : Introduction épistémologique aux apports de la phénoménologie au concept d'habiter », *Cybergeo : European Journal of Geography* [En ligne], *Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique, Document* 216.

Hoyaux André-Frédéric, « Habiter : se placer plaçant et se penser pensant », *Annales de géographie*, 2015/4, n° 704, p. 366-384.

Hoyaux André-Frédéric, « Corps en place, place du corps », *L'Information géographique*, 2016/2, vol. 80, n° 2, p. 11-31.

2.3.2. L'habiter comme structure existentielle

Habiter : déployer un monde à partir d'un ancrage

> une structure fondamentale du Dasein qui engage :

- le corps
- le monde
- le sens

L'habiter comme mode d'être

"Etre-dans" un monde = habiter ce monde

La structure tripolaire de l'habiter

- ancrage corporel
- déploiement spatial
- tonalité affective

L'espace vécu et la notion de « milieu » (*Umwelt*)

La « distance existentielle »

Le corps comme condition de possibilité de l'habiter

Habiter suppose un "je peux" spatial

Habiter un lieu et habiter son corps forment une continuité phénoménologique

(Merleau-Ponty) :

- le lieu est incorporé
- le schéma corporel s'étend à l'espace
- le savoir-faire spatial est pré-réflexif (trouver son chemin, agir dans le noir)

> Continuité phénoménologique entre « habiter un lieu » et « habiter son corps »

Seuils, frontières et rythmes

Les seuils sont des « opérateurs existentiels » :

- . entre le dedans et le dehors
- . entre le privé et le public
- . entre l'intime et l'exposé, etc.

Fonctions des frontières :

- . protection / exposition
- . intimité / visibilité
- . continuité / rupture, etc.

> Le « chez-soi » est un « centre existentiel »

L'habiter comme processus de familiarisation

Processus temporel de l'habiter :

- découverte
- exploration
- familiarisation
- appropriation, etc.

Le quotidien est une « rythmique de l'habitation » :

- micro-rituels
- trajets récurrents

- allers-retours répétés, etc.
- + maintien d'une part d'étrangeté : le familier n'épuise jamais totalement le lieu

Atmosphères et dimension pathique de l'espace

Les lieux nous affectent avant d'être pensés :

- accueillants ou hostiles
- légers ou lourds
- ouverts ou fermés, etc.

L'habiter est donc un accordage affectif au milieu :

- sécurité
- confiance
- inquiétude
- malaise, etc.

Dimensions intersubjectives de l'habiter

Habiter est toujours déjà co-habiter :

- famille
- couple
- colocation
- résidents, etc.

> L'« hospitalité » devient une structure centrale

Figures existentielles de l'habiter

- s'installer
- circuler
- se retirer / se protéger
- accueillir : hospitalité, intersubjectivité.
- explorer, etc.

Habiter, quotidien et bien-être

Georges Perec, *Espèces d'espaces*, Paris, Galilée, 1974 (coll. L'Espace critique)

Georges Perec, *Tentative d'épuisement d'un lieu parisien*. Paris : Christian Bourgois, 1982.

Georges Perec, *Lieux*, Paris, Seuil, 2022 (posthume)

Habiter comme condition du quotidien :

- inscription des routines dans l'espace domestique ou professionnel
- soutien de la répétition et de la continuité

Habiter comme condition du bien-être :

- « Être bien » suppose « être quelque part »
- la stabilité spatiale soutient la sécurité ontologique

Le mal-être comme crise de l'habitation :

- une déstructuration du "chez-soi"
- un sentiment d'étrangeté dans le familier
- une errance, etc.

L'habiter est une *structure existentielle* car il organise conjointement :

- la spatialité : un monde praticable
- l'affectivité : les *Stimmungen*, ambiances et atmosphères
- l'identité : le "chez-soi", les appartenances

- la normativité : le possible/impossible, le licite/interdit

2.3.3. Psychopathologie de l'habiter

L'agoraphobie : rupture de la familiarité spatiale

- perte du sol porteur
- dimension corporelle
- espace sans limites
- dépendance à l'objet/personne contraphobique
- spatialité rétrécie, ...

La claustrophobie : enfermement spatial

- oppression par l'espace
- panique du sans-issue
- enserrement du corps propre, ...

La dépression : délabrement de l'espace habité

- aplatissement spatial
- perte de la dimension de hauteur
- le monde devient un fardeau
- « déshabitation », ...

La schizophrénie : désarticulation de l'espace vécu

- perte de la cohérence spatiale
- troubles de la proxémique
- expériences spatiales étranges
- impossibilité de s'installer, ...

L'addiction : rétrécissement de l'espace vital

- spatialité organisée par la substance
- perte de la dimension d'altérité
- enfermement, ...

Le traumatisme : hantise des lieux

- impossibilité d'accès
- intrusions spatiales
- perte de l'habitation sécurisante, ...

Figures phénoménologiques : dimensions de l'habiter et formes cliniques typiques

Dimension de l'habiter (structure)	Ce qui se dérègle (phénoménologie)	Manifestations cliniques typiques	Exemples de pathologies / situations
Ancrage corporel (habiter son corps)	Désappropriation du corps, corps étranger, "je ne suis pas là"	Dépersonnalisation, anesthésie émotionnelle, dissociation, hypervigilance	Troubles dissociatifs / PTSD, troubles somatoformes, dépression sévère, anxiété avec sensations envahissantes
Schéma corporel / "je peux" (capacité d'agir)	Rétrécissement du champ du possible, perte du "je peux"	Évitements, inhibition, immobilité, incapacité à sortir/faire, dépendance aux routines	Agoraphobie/panique, dépression, troubles anxieux, certaines psychoses (désorganisation)
Centre / chez-soi	Perte du centre,	Errance, agitation,	Précarité/SDF, états limites en

(point de tenue)	impossibilité de "se poser"	impossibilité de "rester en place", sentiment d'insécurité au domicile	crise, manie/hypomanie, PTSD après effraction/violence
Familiarité du monde	Le familier ne porte plus, monde devenu opaque	Perte d'évidence, fatigue d'exister, sentiment que "rien ne va de soi"	Dépression, burnout, anxiété, prodromes psychotiques
Étrangeté / Unheimlichkeit (inquiétante étrangeté)	Le familier devient menaçant, inquiétant	Angoisse "sans objet", malaise à la maison, peur des pièces/ombres/bruits	Troubles anxieux, PTSD, troubles obsessionnels (hyper-contrôle), symptômes psychotiques (déréalisation)
Seuils / frontières (dedans–dehors)	Frontières trop perméables ou trop rigides	Intrusion vécue, hypercontrôle des accès, difficulté à sortir/laisser entrer	PTSD (intrusion), obsessions/compulsions (rituels de seuil), troubles paranoïaques, anxiété sociale
Rythmes et routines (stabilisation quotidienne)	Effondrement des rythmes ou rigidification extrême	Désorganisation, errance temporelle, ou au contraire ritualisation contraignante	Dépression (ralentissement), manie (accélération), rituels, troubles autistiques
Hodologie (trajets / itinéraires)	Le monde n'est plus praticable, les trajets deviennent menaçants	Évitement des transports/lieux, zones interdites, panique en déplacement	Phobies spécifiques, PTSD (lieux déclencheurs), troubles de l'orientation dans certaines neurocognitions
Atmosphères (dimension pathique)	Atmosphères vécues comme lourdes/hostiles/vides	"L'air est irrespirable", oppression, vide, dérégulation émotionnelle liée aux lieux	Dépression mélancolique, anxiété, psychose (atmosphères persécutives), trauma (lieux saturés)
Normativité du lieu (ce qui se fait/ne se fait pas)	Perte des règles implicites ou sur-normativité	Conduites inadaptées, transgressions, honte, ou rigidité morale	Psychose (désajustement), troubles obsessionnels, trouble anxieux social, certaines addictions
Intersubjectivité (co-habiter)	Conflits d'usage, fusion, intrusion, isolement	Hypervigilance domestique, querelles territoriales, retrait, impossibilité de partager	États limites (instabilité relationnelle), violence conjugale/familiale, dépression (repli), troubles paranoïaques
Hospitalité (ouvrir/fermer)	Incapacité d'accueillir ou incapacité de se protéger	Isolement extrême ou envahissement, difficultés d'intimité	Dépression, anxiété sociale, PTSD, dépendance affective, certaines organisations limites
Territorialisation spatiale (appropriation)	Déterritorialisation : plus de repères/prises	"Je n'ai pas de place", impossibilité de s'installer, sentiment d'inexistence sociale	Migration/exil, hospitalisation, institutionnalisation, précarité résidentielle
Habiter comme co-constitution sujet–milieu	Rupture sujet / environnement : monde hostile ou indifférent	Sentiment d'irréalité, retrait, incapacité à investir	Dépression, psychose, dissociation, addictions (retrait du monde praticable)

2.3.4. Habiter, (se) territorialiser : le « Soi territorial » et l'habitation du corps

(Se) territorialiser :

- produire un territoire, un lieu
- + se produire soi-même
- > référence au concept de "constitution" (sujet/objet transcendantal)
- + mobilisation des notions de Moi et de Soi

Distinctions opératoires :

- lieu : ce qui est localisable
- milieu : ce qui est praticable
- territoire : ce qui est approprié, signifiant, marqué, défendu, etc.

Gilles Deleuze, Félix Guattari, *Capitalisme et schizophrénie*, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980.

Genèse du territoire : du corps au monde

Le *corps propre* est le territoire originaire

La première territorialisation est le « schéma corporel », permettant les articulations structurantes fondamentales :

- l'ici et le là-bas
- le dedans et le dehors
- le proche et lointain
- le possible et l'impossible, etc.

Les frontières corporelles. Cf. D. Anzieu, *Le Moi-peau* :

- la peau comme limite et interface
- la porosité et étanchéité du corps vécu

Les atteintes aux frontières corporelles (trauma, violence, maladie, vieillissement) = désappropriations corporelles :

- corps familial
- corps étranger
- corps objectivé, etc.

Les strates de territorialisation : du corps à l'espace habité

- la territorialisation primaire (zones de sécurité/de menace...)
- le péricorporel (sphère de l'intime, vêtements, objets portés...)
- l'espace domestique (le "chez-soi" qu'on appelle "mon intérieur")
- les micro-territoires ("ma place", "mon coin"...)
- les territoires élargis (quartier, chemins, lieux culturels, conviviaux...)

Le « Soi territorial »

Définition phénoménologique :

- Le Soi territorial désigne la forme de soi produite par l'appropriation spatiale
- > l'identité n'est pas seulement psychique ou narrative : elle est aussi « topologique »

Les pratiques quotidiennes de territorialisation

- par le geste
- par les objets
- par la répétition

- par les seuils
 - par le langage
- > le quotidien est une « sédimentation territoriale »

Territorialisation et déterritorialisation

Le territoire comme soutien la sécurité ontologique et existentielle

La déterritorialisation (précarité résidentielle, hospitalisation, exil, migration...)

Implications thérapeutiques et professionnelles

Accompagnement, thérapie > « reterritorialisation »

- refaire des centres, des seuils, des périmètres
- reconstruire des micro-territoires, etc.

